

DİŞ ÇEKİMİ VE DENTAL İMPLANT CERRAHİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

Hasta Adı Soyadı:	T.C. Kimlik No:	Tarih: / / 20.... Saat: :
----------------------------	--------------------------	--

1. Teşhis / İşlem Planlanan Diş veya Bölge

Hekim; çekim, gömülü diş cerrahisi, implant ve/veya ek cerrahi planlanan diş/bölgeleri şema üzerinde işaretler; klinik planı aşağıya yazar.

Üst Çene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
Alt Çene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Teşhis / işlem bölgesi:	Çekim nedeni / gömülü diş / implant planlanan bölge:
Planlanan işlem:	Basit çekim / cerrahi çekim / gömülü diş çekimi / dental implant / immediate implant / greft / membran / sinüs lifting / yumuşak doku işlemi / diğer:
Planlanan implant sayısı / ek cerrahi / özel not:	

2. Lokal Anestezi Bilgilendirmesi ve Komplikasyonları

İşlem sırasında gerekli görülürse lokal anestezi uygulanabilir. Kliniğimizde lokal anestezi amacıyla lidokain ve/veya artikain etken maddeli, adrenalinli veya adrenalinli anestezi solüsyonları kullanılır. Lokal anestezi uygulanacak bölgede sinir iletimini geçici olarak azaltır veya durdurur; uyuşukluk kişiye, uygulama bölgesine ve kullanılan ilaca göre değişmekle birlikte yaklaşık 1-4 saat sürebilir. Lokal anestezi sonrası geçici uyuşukluk, dudak/yanak/dil ısırmaya bağlı travma, enjeksiyon bölgesinde ağrı, ödem, morarma, kas spazmi, çene açmada kısıtlılık, geçici kas zayıflığı, geçici yüz felci, geçici his kaybı, anestezinin yetersiz kalması veya tekrarlanması ihtiyacı görülebilir. Nadir olarak lokal anesteziye veya içeriğindeki maddelere bağlı alerjik reaksiyon, kaşıntı, döküntü, anjiyoödem, tansiyon değişikliği, çarpıntı, solunum güçlüğü ve anafilaksi/anafilaktik şok gelişebilir; bu durumda acil tıbbi müdahale gerekebilir.

3. DİŞ ÇEKİMİ VE GÖMÜLÜ DİŞ CERRAHİSİ ☐

Kapsam: Bu bölüm basit diş çekimi, cerrahi çekim, kök parçası çıkarılması ve gömülü/yarı gömülü diş cerrahisini kapsar.

İşlemden beklenen faydalar: Tedavi edilemeyen, ağrı/enfeksiyon odağı oluşturan, kırık, ileri çürük, ileri periodontal kayıplı, protetik/ortodontik planlama gereği çekimi gereken veya çevre dokulara zarar verme riski taşıyan diş/köklerin uzaklaştırılması; ağrı ve enfeksiyon riskinin azaltılması, çevre dokuların korunması ve ileri tedavi planına hazırlık sağlanması beklenir.

Gömülü diş cerrahisi özel bilgilendirmesi: Gömülü veya yarı gömülü dişlerde diş eti kesisi, flep kaldırılması, kemik kaldırılması, dişin parçalara ayrılarak çıkarılması, dikiş atılması ve ileri yara bakımı gerekebilir. Alt yirmi yaş dişlerinde dudak-çene ucu veya dilde geçici/kalıcı uyuşukluk; üst bölgelerde sinüs ile ilişki, sinüs açıklığı veya burundan sıvı/hava gelmesi riski oluşabilir. Kök parçası çıkarılamayabilir veya klinik gereklilik halinde yerinde bırakılıp takip edilebilir.

İşlem nasıl yapılır, nerede/kim tarafından yapılır ve tahmini süre: İşlem, hekimleri tarafından uygulanır. Lokal anestezi sonrası diş el aletleri, elevatör ve/veya davye yardımıyla çıkarılır. Cerrahi veya gömülü vakalarda kesi, kemik kaldırma, dişi bölme, küretaj, yıkama, dikiş ve kanama kontrolü uygulanabilir. Tahmini süre basit çekimde çoğunlukla 10-30 dakika; cerrahi/gömülü dişlerde 30-90 dakika olabilir; dişin konumu, kök şekli, enfeksiyon, kemik yapısı ve hasta uyumuna göre değişebilir.

Alternatifler: Uygun vakalarda dolgu, kanal tedavisi, kuren/onley, periodontal tedavi, apikal cerrahi, ortodontik sürdürme, takip veya geçici medikal tedavi değerlendirilebilir. Her alternatif her hasta ve diş için uygun olmayabilir.

Riskler ve komplikasyonlar: Kesin komplikasyonsuz sonuç garantisi verilemez. Ağrı, şişlik, morarma, kanama, enfeksiyon, alveolit, dikiş açılması, yara iyileşmesinde gecikme, trismus, çene eklemi/kas ağrısı, kök kırılması, kök/diş parçasının çıkarılamaması veya yer değiştirmesi, komşu diş/restorasyon/protez hasarı, sinüs açıklığı/perforasyonu, kemik veya tüber kırığı, nadiren çene kırığı, alt dudak-dil-çene ucu veya damakta geçici/kalıcı uyuşukluk ve ek cerrahi ihtiyacı oluşabilir.

İşlem yapılmazsa ne olur: Gerekli çekim veya gömülü diş cerrahisi yapılmazsa ağrı, çürük veya enfeksiyon ilerleyebilir; apse, yüzde şişlik, fistül, kist, komşu dişlerde hasar, kök erimesi, kemik kaybı, ağız kokusu ve çiğneme bozukluğu gelişebilir. Gömülü dişlerde tekrarlayan enfeksiyon, diş diziliminde sorun ve kistik oluşum riski artabilir.

İşlem öncesi/sonrası dikkat ve hastanın belirtmesi gereken durumlar: Hasta sistemik hastalıklarını, kullandığı ilaçları, kan sulandırıcı, bifosfonat/osteoporoz ilacı, kemoterapi/radyoterapi öyküsünü, alerjilerini, gebelik durumunu ve sigara kullanımını hekime bildirmelidir. İşlem sonrası gaz tamponu önerilen süre ısırmalı; ilk saatlerde tükürme, çalkalama, pipet, sigara, alkol, sıcak gıda ve sert çiğnemenin kaçınılmasıdır. Devam eden kanama, artan şişlik, ateş, kötü tat/koku, şiddetli ağrı, uyuşukluk veya dikiş açılması olursa kliniğe başvurulmalıdır.

4. DENTAL İMPLANT CERRAHİSİ ☐

Kapsam: Bu bölüm dental implant yerleştirilmesi, immediate implant, kemik grefti, membran, yumuşak doku işlemleri, ikinci cerrahi ve sinüs lifting gibi implantla ilişkili ek cerrahileri kapsar.

İşlemden beklenen faydalar: Eksik diş bölgesine yerleştirilen implantların iyileşme sonrası sabit veya hareketli protezlere destek olması; çiğneme, konuşma, estetik ve kapanış fonksiyonlarının iyileştirilmesi; uygun vakalarda kemik/doku desteğinin korunmasına katkı sağlanması beklenir.

Implant cerrahisi özel bilgilendirmesi: Klinik ve radyolojik değerlendirme sonrası diş eti açılarak veya uygun vakalarda kapalı teknikte kemikte yuva hazırlanır ve implant yerleştirilir. Kapama vidası veya iyileşme başlığı kullanılabilir. Kemik yetersizliği veya anatomik gereklilik halinde kemik grefti, membran, yumuşak doku düzenlemesi, ikinci cerrahi, immediate implant ya da tedavi planında değişiklik gerekebilir. İmplantın kemikle kaynaşması garanti edilemez; iyileşme süreci ve protez aşaması hastaya göre değişir.

Sinüs lifting özel bilgilendirmesi: Üst çene arka bölgede kemik yüksekliği yetersizse kapalı/crestal veya açık/lateral pencere tekniği ile sinüs lifting yapılabilir. Sinüs membranı yükseltilecek kemik grefti yerleştirilebilir; implant aynı seansta yerleştirilebilir veya kemik iyileşmesi için ertelenebilir. Sinüs membranı perforasyonu, sinüzit, greft kaybı, ağız-sinüs ilişkisi, burun kanaması, burundan sıvı/hava gelmesi, ek cerrahi veya KBB değerlendirmesi ihtiyacı gelişebilir. İşlem sonrası sümürmemek, hapşırırken ağız açık tutmak, pipet kullanmamak ve basınç artıran davranışlardan kaçınmak gerekir.

İşlem nasıl yapılır, nerede/kim tarafından yapılır ve tahmini süre: İşlem, hekimleri tarafından uygulanır. Lokal anestezi altında implant yuvası hazırlanır, implant yerleştirilir, gerekli görülürse greft/membran/sinüs lifting/yumuşak doku işlemleri yapılır, dikiş atılabilir. Tahmini süre tek implantta çoğunlukla 20-60 dakika; çoklu implant ve ek cerrahilerde 60-120 dakika veya daha uzun olabilir; süre kemik durumu, implant sayısı, anatomik yakınlık ve ek cerrahi gereksinimine

göre değişebilir.

Alternatifler: Köprü protezi, hareketli protez, mevcut protezin düzenlenmesi, implant sayısının veya planın değiştirilmesi, greft/ileri cerrahinin ertelenmesi ya da tedavisiz takip seçenekleri değerlendirilebilir. Her seçenek her hasta, kemik yapısı, genel sağlık durumu ve ekonomik/klinik koşul için uygun olmayabilir.

Riskler ve komplikasyonlar: Kesin başarı veya komplikasyonsuz sonuç garantisi verilemez. Ağrı, şişlik, morarma, kanama, enfeksiyon, dikiş açılması, yara iyileşmesinde gecikme, implantın kemikle kaynaşmaması, implant kaybı, periimplantitis, kemik/diş eti çekilmesi, estetik memnuniyetsizlik, implant/protez vidası, abutment veya kron gevşemesi/kırılması, sinir hasarı/uyuşukluk, sinüs komplikasyonları, greft kaybı, ikinci cerrahi, ileri takip ve revizyon ihtiyacı görülebilir.

İşlem yapılmazsa ne olur: Eksik diş bölgesi tedavi edilmezse çiğneme/konuşma fonksiyonu, estetik görünüm ve kapanış dengesi etkilenebilir; komşu dişlerde devrilme, karşıt dişte uzama, gıda birikimi, periodontal sorunlar, kemik hacminde azalma ve protez planının zorlaşması görülebilir.

İşlem öncesi/sonrası dikkat ve hastanın belirtmesi gereken durumlar: Hasta sistemik hastalıklarını, diyabet kontrolünü, sigara kullanımını, kan sulandırıcı, bifosfonat/osteoporoz ilacı, kemoterapi/radyoterapi öyküsünü, alerjilerini ve kullandığı ilaçları hekime bildirmelidir. İşlem sonrası reçete edilen ilaçları tarif edildiği şekilde kullanılmalı, ilk 24 saat tükürme/çalkalama/pipet/sigara/alkol/sıcak gıdadan kaçınmalı, soğuk uygulama ve ağız hijyeni önerilerine uymalıdır. Implant/protez hareketi, devam eden kanama, artan şişlik, ateş, kötü tat/koku veya uyuşuklukta kliniğe başvurulmalıdır.

5. Kullanılabilecek İlaçlar, Materyaller ve İstenmeyen Etkiler

İşlem öncesi veya sonrası gerekli görülürse lokal anestezi, antibiyotik, ağrı kesici, antienflamatuvar, antiseptik gargara, mide koruyucu veya hekimin uygun gördüğü diğer ilaçlar kullanılabilir/reçete edilebilir. Bu ilaçlara, lokal anesteziye, dikiş materyaline, greft/membran materyallerine, implant ve cerrahi materyallere bağlı mide bulantısı, ishal, mide rahatsızlığı, baş dönmesi, uyku hali, cilt döküntüsü, kaşıntı, kontakt irritasyon, alerjik reaksiyon ve nadiren anafilaksi gelişebilir. Solunum güçlüğü, yaygın döküntü/kaşıntı, dudak-dil-boğaz şişliği, baygınlık hissi veya hızlı kötüleşme olursa acil tıbbi yardım alınmalıdır.

6. Onam Beyanı

Yukarıdaki bilgileri okudum. Diş çekimi, gömülü diş cerrahisi, dental implant cerrahisi ve gerekli görülürse ek cerrahi işlemlerin nasıl yapılacağı, tahmini süreleri, işlemten beklenen faydaları, alternatifleri, yapılmazsa oluşabilecek sonuçları, lokal anestezi ve ilaç/materyal riskleri, işlem öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar, riskler ve komplikasyonlar hakkında hekimim tarafından anlayabileceğim şekilde bilgilendirildim. Bu formdaki bilgiler tarafıma hekimim tarafından sözlü olarak açıklanmıştır. Soru sorma fırsatı buldum, sorularım yanıtlandı. İşlemlerin kesin başarı ve komplikasyonsuz sonuç garantisi taşımadığını; işlem sırasında ortaya çıkabilecek klinik duruma göre ek cerrahi, tedavi planı değişikliği veya ileri takip gerekebileceğini anladım. Belirtilen cerrahi işlemlerin uygulanmasını kabul ediyorum.

7. İmza Alanı

Hasta el yazısı ile:

(noktalı alana "okudum anladım onaylıyorum" yazınız)

Hasta / Yasal Temsilci - Ad Soyad / İmza / Tarih:

Hekim - Ad Soyad / İmza / Tarih:

Yasal temsilci imzasında yakınlık derecesi ve temsil nedeni hasta dosyasına ayrıca kaydedilir.